DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: JESUS ANTONIO RAMIREZ DAVILA **Identificación** CC 6132092
Edad: 83 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS S.A CONTRIBUTIVO-2025
Sala: QUIROFANO 3 **Fecha programación de cirugía:** 10/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**511102**	**COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA (TRANSDUODENAL)**	Y57	

Cirujano: JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad:** CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Vía: ABDOMEN

1	**518501**	**ESFINTERECTOMIA Y PAPILOTOMIA, VIA ENDOSCOPICA**	Y58	

Cirujano: JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad:** CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Vía: ABDOMEN

1	**518801**	**EXTRACCION ENDOSCOPICA DE CALCULOS DE LAS VIAS BILIARES CON ESFINTEROTOMIA**	Y59	

Cirujano: JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad:** CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Vía: ABDOMEN

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES152 JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad** CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA

511102 **COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA (TRANSDUODENAL)**
518501 **ESFINTERECTOMIA Y PAPILOTOMIA, VIA ENDOSCOPICA**
518801 **EXTRACCION ENDOSCOPICA DE CALCULOS DE LAS VIAS BILIARES CON ESFINTEROTOMIA**

Dx Preoperatorio: K805 CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS

Dx Postoperatorio: K805 CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 10/11/26 **Fecha Final** 10/11/26
Hora Inicio 07:40:00 **Hora Final** 09:00:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:

PACIENTE DECUBITO LATERAL IZQUIERDO SEDACION PROFUNDA SE INTRODUCE DUODENOSCOPIO OLYMPUS TJFQ -180 UV HASTA LA SEGUNDA PORCION DEL DUODENO IDENTIFICANDO PAPILA DUODENAL MAYOR DE CARACTERISTICAS YA SEÑALADAS, SE INTENTA CANULACION CON ESFINTEROTOMO CURVO Y GUIA HIDROFILICA EN VARIAS OCASIONES SIN EXITO, POR LO CUAL DECIDIMOS PASAR A REALIZAR PRECORTE CON ESFINTEROTOMO RECTO LOGRANDO CANULACION DE LA VIA BILIAR PRINCIPAL. SE PASA CONTRASTE Y TOMA DE IMAGENES CON INTENSIFICADOR ARCO EN C, CORROBORANDO HALLASGOZ DESCRITOS. SE AMPLIA LA PAPILOTOMIA CON ESFINTEROTOMO CURVO REALIZAMOS BARRIDO DE LA VIA BILIAR CON BALON EXTRACTOR OBTENIENDO CALCULO DE APROX 1.5 CM BARRO BILIAR Y MICROLITOS. SE CONTRASTA NUEVAMENTE CON BALON ENCLAVADO EN LA PAPILA CORROBORANDO AUSENCIA DE DEFECTOS DE LLENO, SE REVISA HEMOSTASIA Y ADECUADO DREANEJE DE BILIS
DAMOS POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO.

Complicaciones : **SI** [ ] **NO** [X]

Hallazgos :

CONCLUSION
1.PAPILA DUODENAL MAYOR EDEMATOSA TIPO II
2. ESFINTEROTOMIA CON PRECORTE
3. VIA BILIAR INTRA Y EXTRA HEPATICA CON DILATACION MODERADA
4. COLEDOCO LITIASIS RESUELTA

Tejidos enviados a patología : **SI** [ ] **NO** [X]

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ
Reg. 1115066530
CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***